複雑性PTSD（C-PTSD）の診断と治療 — 内科・総合診療医が知っておくべき実践知識

30分レクチャー脚本

作成日: 2026-03-20 **対象:** 内科・精神科・総合診療科の研修医〜若手医師 **参照文献:** `/Users/torukubota/ai-management/docs/pubmed/2026-03-20_complex_PTSD_treatment_evidence.md`

スライド構成一覧

#	スライドタイトル	目安時間
1	オープニング：症例提示	1.5分
2	C-PTSDとは何か	1.5分
3	ICD-11診断基準：DSO（自己組織化の障害）	2分
4	通常PTSDとの臨床的な違い	2分
5	見落とされやすい場面	1分
6	フェーズ基盤型アプローチの全体像	2分
7	なぜ急いでトラウマ処理をしてはいけないか	2分
8	フェーズ1〜4の実際	1分
9	EMDR — 大きな効果量と解離症状の落とし穴	2分
10	TF-CBT/PE/CPT — 強力だが脱落率に注意	2分
11	DBT-PTSD — JAMA Psychiatryの衝撃的結果	2分
12	薬物療法 — 補助療法の位置づけ	2分
13	スキーマ療法・IFS — 有望だがまだ研究段階	2分
14	どれを選ぶか：実践的判断フロー	2分
15	C-PTSDを疑うべきサイン5つ	1分
16	紹介のタイミングとやってはいけないこと	2分
17	キーメッセージの復習と質疑応答	2分
合計		**30分**

オープニング（3分）

スライド1：症例提示（1.5分）

[スライドに映す内容] - 40代女性、主訴：慢性腰痛・不眠・「原因不明の疲労」 - 整形外科→消化器内科→心療内科と転々 - 現在もう6つ目の外来受診

脚本: 「今日は一人の患者さんから始めましょう。40代の女性で、慢性腰痛と不眠を主訴に外来を受診しています。整形外科では『骨には異常なし』、消化器内科では『胃カメラも問題なし』、そして心療内科では『うつ病の疑いでSSRI開始、でもあまり効かない』と言われて、今日みなさんの外来に6つ目の受診です。

カルテを開くと、こんなことが書いてあります。『感情的になりやすい』、『医療者との信頼関係を構築しにくい』、『治療へのアドヒアランスが悪い』。

さて、皆さんはこの患者さんを診て、何を考えますか？実はこの方、10年以上のパートナーからのDV歴があります。この女性が抱えているのは、うつ病でも、慢性疼痛でも、パーソナリティ障害でもなく——複雑性PTSD、C-PTSDである可能性が非常に高いんです。」

スライド2：C-PTSDとは何か（1.5分）

[スライドに映す内容] - 2018年 ICD-11 で独立疾患単位として収載 - 通常PTSD + 「自己組織化の障害（DSO）」 - 原因：反復・長期・逃れにくいトラウマ（虐待・DV・人身売買・拷問）

脚本: 「複雑性PTSDは、2018年にWHOのICD-11に正式に収載された、比較的新しい疾患概念です。DSM-5にはまだ独立した診断名がなく、この言葉を知らない医師が多いのが現状です。

通常のPTSDは、交通事故や自然災害のような一回性の出来事がきっかけになることが多い。これに対してC-PTSDは、逃げることができない環境での、反復して長期にわたるトラウマ体験が原因です。幼少期の虐待、長期にわたるDV、拷問、難民経験——こういった背景を持つ患者さんが対象になります。

そして重要なのは、通常PTSDとは症状の構造が違う、ということです。この違いを理解することが今日のレクチャーの第一歩です。」

第1章：C-PTSDを理解する（5分）

スライド3：ICD-11診断基準 — DSO（自己組織化の障害）（2分）

[スライドに映す内容] - 【通常PTSD 3症状群】 - 再体験（フラッシュバック・悪夢） - 回避 - 過覚醒（過度の警戒・易驚愕） - 【C-PTSD追加】DSO（自己組織化の障害） - 情動調節困難（感情の爆発・麻痺） - 否定的自己概念（「自分はダメだ」「穢れている」） - 対人関係障害（人を信じられない・親密さへの恐怖）

脚本: 「ICD-11のC-PTSD診断基準を見てみましょう。まず通常PTSDの3症状群——再体験、回避、過覚醒——これはみなさんご存知ですよね。

C-PTSDではこれらに加えて、DSOと呼ばれる『自己組織化の障害』という三つの症状群が必要です。

一つ目が情動調節困難。感情の爆発が起きたり、逆に感情が全くなくなる麻痺が起きたり、この振れ幅が非常に大きい。

二つ目が否定的自己概念。『自分は価値がない』、『自分は汚れている』、『自分が悪かった』という深い自責感です。

三つ目が対人関係障害。人を信頼することが極めて難しく、親密な関係を作ることへの恐怖があります。

先ほどの患者さんに当てはめてみてください。感情的になりやすい——情動調節困難ですね。医療者との信頼構築が難しい——対人関係障害です。治療への不参加——否定的自己概念から来る無力感かもしれません。これらを『問題患者』と切り捨てていたら、正しい診断には永遠にたどり着けません。」

スライド4：通常PTSDとの臨床的な違い（2分）

[スライドに映す内容] | | 通常PTSD | C-PTSD | |–|———|———| | トラウマ | 一回性・限定的 | 反復・長期・逃れられない | | 自己感覚 | 比較的保たれる | 根本から傷ついている | | 対人関係 | 特定のトリガーで悪化 | 全般的に障害されている | | 解離症状 | 軽度〜中等度 | 高頻度・重篤 | | 治療反応 | 標準PTSD治療で効く | フェーズ準備なしには効きにくい |

脚本: 「この表を見てください。通常PTSDとC-PTSDの違いを臨床的にまとめました。

最も重要なのは右の列——C-PTSD患者は、自分自身の存在の根っこから傷ついています。自己感覚が根本から変容している。だから一回や二回の外来で信頼関係を築くことは、まず不可能に近い。

そして解離症状です。C-PTSD患者では解離が高頻度かつ重篤に現れます。解離とは、簡単に言うと、現実から意識が切り離されていくような感覚です。診察中に急に目が空ろになったり、質問の内容が全く入っていなかったり——こういうことが起きます。

一番下の行が、今日最も大事なポイントです。C-PTSD患者に、通常PTSDと同じつもりでトラウマ処理を始めても、うまくいかないどころか悪化することがある。なぜかは次のスライドで説明します。」

スライド5：見落とされやすい場面（1分）

[スライドに映す内容] - 慢性疼痛（腰痛・頭痛・原因不明の体の訴え） - 身体表現性障害・機能性障害の診断がついている - 「治療抵抗性うつ病」として複数の抗うつ薬を試されている - 「境界性パーソナリティ障害（BPD）」診断に埋没している

脚本: 「C-PTSDが見落とされやすい場面を4つ挙げます。内科外来ではまず慢性疼痛や機能性障害として来ます。精神科では治療抵抗性うつ病、あるいはBPDという診断に落ち着いていることが多い。

特に注意したいのはBPDとの関係です。BPDの多くは幼少期の虐待歴を持ち、C-PTSDとの重複が非常に多い。でもBPDという診断だけがついていると、根底にあるトラウマが見逃されてしまう。『問題患者』として片付けないこと——これを肝に銘じてください。」

第2章：治療の原則 — フェーズ基盤型アプローチ（5分）

スライド6：フェーズ基盤型アプローチの全体像（2分）

[スライドに映す内容] - ISTSSガイドライン 2018（PMID: 31283056）が強く推奨 - 361件のRCT、208件のメタ解析に基づくガイドライン - フェーズ基盤型4段階： 1. 安全確立（Safety） 2. 安定化（Stabilization） 3. トラウマ処理（Trauma Processing） 4. 社会統合（Reintegration）

脚本: 「さて、C-PTSDの治療の原則を話しましょう。最も重要なガイドラインはISTSS、国際トラウマティックストレス学会の2018年版ガイドラインです（PMID: 31283056）。361件のRCTと208件のメタ解析に基づいた、現時点で最も包括的な指針です。

このガイドラインがC-PTSDに対して強調しているのが、フェーズ基盤型アプローチという考え方です。4つの段階があります。

まず第1フェーズが『安全確立』——今この患者さんは安全な場所にいるか。DVが継続中なら、まずそこを何とかしなければ何も始まらない。

第2フェーズが『安定化』——感情を自分でコントロールできるスキルを身につける。

第3フェーズが『トラウマ処理』——ここでようやくトラウマの記憶に向き合う。

第4フェーズが『社会統合』——日常生活や対人関係の中に戻っていく。

この順番を守ることが、C-PTSD治療の鉄則です。」

スライド7：なぜ急いでトラウマ処理をしてはいけないか（2分）

[スライドに映す内容] - 感情調節スキルが不十分な状態でトラウマ記憶を掘り起こすと… - 解離の悪化 - 自傷・希死念慮の増悪 - 治療関係の崩壊 - 治療脱落 - 「急がば回れ」が C-PTSD 治療の核心

脚本: 「では、なぜ急いでトラウマ処理をしてはいけないのか。

これは直感に反するかもしれません。患者さんは苦しんでいる、早く楽にしてあげたい——その気持ちはとても自然です。でも、C-PTSD患者は長期のトラウマによって、感情を調節するシステム自体が傷ついています。

感情調節スキルが十分に育っていない状態でトラウマ記憶に触れると——解離が悪化する、自傷や希死念慮が増悪する、そして治療を辞めてしまう。これが最悪のパターンです。

後で紹介するDBT-PTSDの研究（PMID: 32697288）では、比較対照として使われたCPTという認知処理療法のグループで39%が治療を脱落しました。C-PTSD、特に感情調節障害が強い患者さんに安定化フェーズなしでトラウマ処理を始めることがいかに危険か、この数字が示しています。

『急がば回れ』——これがC-PTSD治療の核心です。」

スライド8：フェーズ1〜4の実際（1分）

[スライドに映す内容] - フェーズ1（安全確立）：DV・ホームレス・自傷の有無確認、社会的資源の整備 - フェーズ2（安定化）：グラウンディング、感情日記、マインドフルネス - フェーズ3（トラウマ処理）：EMDR、PE、CPT、DBT-PTSD - フェーズ4（社会統合）：対人スキル、職場復帰、コミュニティへの参加

脚本: 「各フェーズで実際に何をするかを簡単に確認しておきます。安全確立フェーズでは、まず身体的・社会的安全を確保する。DVが続いているなら、まずシェルターや法的な介入が必要です。

安定化フェーズでは、グラウンディングというスキルを練習します。『今ここにいる』という感覚を取り戻す技術で、足の裏が床についている感覚に意識を向けるといった、シンプルなものです。

そしてトラウマ処理フェーズで初めて、EMDR、CPT、DBT-PTSDといった技法が登場します。詳しく見ていきましょう。」

第3章：各治療法のエビデンス（12分）

スライド9：EMDR — 眼球運動による脱感作と再処理（2分）

[スライドに映す内容] - 効果量（Hedges' g）= -1.26（PTSD症状）※通常ケアとの比較 - Karatzias et al. 2019, RCT 51件メタ解析（PMID: 30857567） - 否定的自己概念・対人関係にも中等度〜大の効果 - ただし解離症状が強い場合は効果が減弱 - 準備フェーズ（解離安定化）が先行必須

脚本: 「第3章、各治療法のエビデンスを見ていきます。まずEMDRです。

EMDRとはEye Movement Desensitization and Reprocessing——眼球運動による脱感作と再処理、という名前の心理療法です。患者さんがトラウマ記憶を思い浮かべながら、セラピストの指の動きを目で追う——そういった手続きを通じて、記憶の感情的な強度を下げていく技法です。

Karatzias らのメタ解析（2019年、PMID: 30857567）では、51件のRCTを解析して、EMDRのPTSD症状に対する効果量はHedges' g = -1.26。これは非常に大きな効果量です。さらに、否定的自己概念や対人関係にも中等度から大の効果量を示しました。

でも、注意してほしいポイントがあります。解離症状が強い患者さんでは効果が著しく落ちます。また、幼少期発症のトラウマほど効果が下がる傾向がある。だからこそ、解離症状への安定化介入を先行させてからEMDRに入ることが推奨されています。これを飛ばして急にEMDRを始めると、患者さんが圧倒されてしまうことがあります。」

スライド10：TF-CBT / PE / CPT — 強力だが脱落率に注意（2分）

[スライドに映す内容] - Korovynskyi et al. 2025, RCT 45件 n=4,267（PMID: 40737648） - PE（持続エクスポージャー）d = 1.24 - CPT（認知処理療法）d = 1.16 - TF-CBT d = 1.08 - 治療反応率：PE 68%、CPT 64%、CBT 61% - ただしC-PTSD+感情調節障害では脱落率が高い - DBT-PTSDとの比較RCTでCPT群39%脱落

脚本: 「次はトラウマフォーカスト認知行動療法のグループです。PE、CPT、TF-CBT——これらは最もエビデンスの蓄積が豊富な治療法です。

2025年のKoroyvnskyi らのメタ解析（PMID: 40737648）では、RCT 45件、合計4,267人のデータが解析されました。PE、つまり持続エクスポージャーの効果量はd = 1.24、CPTすなわち認知処理療法がd = 1.16、TF-CBTがd = 1.08。治療反応率もPEで68%、CPTで64%と非常に高い。

では、これをC-PTSD患者に使えるかというと——使えます、ただし『誰に』使うかが非常に重要です。

先ほど少し話しましたが、感情調節障害が強いC-PTSD患者さんでは、CPTとDBT-PTSDを比較したRCTで、CPT群が39%脱落するという結果が出ています。感情の嵐がきたときにそれを乗り越えるスキルがない状態では、治療の刺激についていけなくなる。使える患者さんには非常に強力な武器ですが、適応を見誤ってはいけません。」

スライド11：DBT-PTSD — JAMA Psychiatryの衝撃的結果（2分）

[スライドに映す内容] - Bohus et al. 2020, JAMA Psychiatry, RCT n=193（PMID: 32697288） - DBT-PTSD vs CPT の比較 - 効果量：DBT-PTSD d=1.35 vs CPT d=0.98 - 寛解率：**58.4%** vs 40.7%（有意差あり） - 脱落率：**25.5%** vs 39.0%（有意差あり） - 9ヶ月後フォローアップでも効果維持（Vonderlin 2024） - 対象：幼少期虐待後 C-PTSD + BPD基準3つ以上

脚本: 「さて、ここからが今日のレクチャーのハイライトです。2020年、JAMA Psychiatryに掲載された論文（PMID: 32697288）の結果を見てください。

Bohus らのRCTは、幼少期の虐待によるC-PTSD、かつBPDの診断基準を3つ以上満たす患者193人を対象に、DBT-PTSDとCPTを比較しました。

結果は衝撃的でした。寛解率——DBT-PTSDグループで58.4%に対して、CPTグループは40.7%。そして脱落率——DBT-PTSDが25.5%に対して、CPTは39.0%。DBT-PTSDの方が、効果が高くて、かつ続けられる患者さんが多かったんです。

この効果は9ヶ月後のフォローアップでも維持されていました（Vonderlin 2024）。

DBT-PTSDとは何か。弁証法的行動療法、DBTを基盤にして、そこにトラウマ処理を統合したプログラムです。感情調節スキルをしっかり身につけながら、段階的にトラウマに向き合っていく。外来で45週、あるいは入院プログラムで12週というかなり長期で集中的な治療です。

今日一番覚えてほしいメッセージを言います。幼少期の虐待後C-PTSD、かつ感情調節障害が強い患者さん——このグループには、DBT-PTSDが現時点で最も強いエビデンスを持つ治療法です。」

スライド12：薬物療法 — 補助療法の位置づけ（2分）

[スライドに映す内容] - C-PTSD特化の薬物療法RCTはほぼ存在しない - Bajor et al. 2022, Psychiatry Research（PMID: 36162349）のアルゴリズム - まず睡眠障害を治療する - 悪夢 → **プラゾシン**（α1遮断薬） - 入眠障害 → ヒドロキシジン・トラゾドン - 残存PTSD症状 → SSRI（セルトラリン・パロキセチン） - ケタミン・TMS・サイケデリクスは現在研究段階

脚本: 「次は薬物療法です。まず最初に正直に言います。C-PTSDだけを対象にした薬物療法の質の高いRCTは、実質的にほぼ存在しません。薬物療法は心理療法の補助として使う、という位置づけです。

では何に使えるかというと、まず睡眠障害です。Bajor らの2022年のレビュー論文（PMID: 36162349）がまとめたアルゴリズムによると——悪夢にはプラゾシン。これはα1受容体遮断薬で、ノルアドレナリンの過活動を抑えることで悪夢を軽減します。入眠障害にはヒドロキシジンやトラゾドン。そして睡眠が改善してもPTSD症状が残るようなら、SSRIのセルトラリンやパロキセチンを検討する——という順序です。

よく患者さんや家族から聞かれるんですが、最近話題のケタミンやサイケデリクスはどうなの、と。今の段階では研究段階であり、標準治療として提供できる段階ではありません。

薬は補助です。心理療法ができる環境を整えるための下地として、まず睡眠と過覚醒を薬でコントロールする——それが薬物療法の正しい使い方です。」

スライド13：スキーマ療法・IFS — 有望だがまだ研究段階（2分）

[スライドに映す内容] - スキーマ療法（Schema Therapy: ST） - イメージリスクリプティングとEMDRとの段階的統合（van Hemert 2025, PMID: 41160015） - 難民・治療抵抗例への「橋渡し」として有望 - ただしRCTほぼなし——症例・パイロットレベル - IFS（内的家族システム療法） - Comeau 2024 パイロット n=15（PMID: 38934934） - 16週で53%が臨床的有意な反応 - 自己慈悲・感情調節の改善が特徴的 - 対照試験なし——推奨には至らない

脚本: 「最後にスキーマ療法とIFSを紹介します。どちらも非常に興味深い治療法ですが、正直に言うと現時点では研究段階です。

スキーマ療法は、幼少期に形成された『早期不適応スキーマ』——たとえば『自分は見捨てられる』『自分は欠陥がある』といった深い信念のパターン——に働きかける治療法です。2025年のvan Hemertらのレビュー（PMID: 41160015）では、スキーマ療法とEMDRとイメージリスクリプティングを組み合わせた段階的アプローチで、CAPS-5スコアが重篤から閾値未満まで改善した症例が報告されています。治療抵抗例への橋渡しとして有望ですが、RCTはまだありません。

IFSは内的家族システム療法という、心の中のさまざまな『部分』に働きかける独特の心理療法です。2024年のComeauらのパイロット研究（PMID: 38934934）では、n=15という小さなサンプルですが、16週間のプログラムで53%が臨床的に有意な反応を示し、自己慈悲と感情調節の改善が特徴的でした。対照群がないので推奨はできませんが、今後のRCTに注目です。

現時点では、標準治療として提供するのではなく、専門家が個別に判断する段階の治療法、と理解してください。」

スライド14：どれを選ぶか — 実践的判断フロー（2分）

[スライドに映す内容]

```
C-PTSDと診断/疑い
          ↓
感情調節障害が強い？BPD基準3つ以上？
     YES → DBT-PTSD（第一選択）
     NO  ↓
解離症状が顕著？
     YES → 解離安定化介入 → EMDR
     NO  ↓
```

```
幼少期発症トラウマ？長期的介入が必要？
    YES → STAIR + CPTなどフェーズ基盤型
    NO  ↓
EMDR または PE / CPT
         ↓
すべてに共通：睡眠障害があれば薬物療法を補助的に
```

脚本: 「では、実際の外来で目の前に患者さんがいたとき、どれを選ぶか。シンプルな判断フローをお示しします。

まず最初に聞くべきは——感情調節障害が強いか、BPDの特徴が3つ以上あるか。答えがYESならDBT-PTSDが第一選択です。JAMA Psychiatryのデータが後押しします。

NOなら次は——解離症状が顕著か。YESなら、まず解離安定化の介入をしてからEMDRに進む。

それもNOなら——幼少期発症で長期的介入が必要か。YESならSTAIRを含むフェーズ基盤型アプローチ+CPT。

そうでない比較的シンプルなケースならEMDRやPE、CPTが選択肢になります。

そして全員に共通して——睡眠障害があれば薬物療法を補助的に加える。悪夢にはプラゾシンを忘れないでください。

このフローは絶対のルールではありませんが、専門家への紹介の際の情報整理にも役立ちます。」

第4章：臨床で使えるチェックポイント（3分）

スライド15：C-PTSDを疑うべきサイン5つ（1分）

[スライドに映す内容] 1. 複数の科を転々としている「難治」患者 2. 感情の激しい起伏 or 逆に感情の平板化 3. 医療者への不信・「問題患者」ラベルがついている 4. 慢性疼痛・機能性身体症状が遷延している 5. 反復・長期トラウマの既往（問診で必ず確認）

脚本: 「C-PTSDを疑うべきサインを5つ挙げます。これはスクリーニングのチェックリストとして使ってください。

一つ、複数科を転々としている難治患者さん。二つ、感情の激しい波、または逆に全く感情が見えない平板化。三つ、医療者への不信感が強く、カルテに問題患者と書かれている。四つ、慢性疼痛や機能性身体症状が長引いている。五つ——そして最も重要、反復・長期にわたるトラウマの既往。

この5番目、問診で意識的に聞かないと絶対に出てきません。『幼少期に何か大変なことはありましたか』『以前の生活の中で怖い思いや傷ついた経験はありましたか』——こういう形で丁寧に尋ねる習慣をつけてください。」

スライド16：紹介のタイミングと「やってはいけないこと」3つ（2分）

[スライドに映す内容] 紹介のタイミング： - 自傷・希死念慮があるとき（緊急） - 解離症状が顕著なとき - 感情調節障害が強く通常の外来対応が困難なとき

紹介先の選び方： - DBT提供できる精神科・心療内科クリニック - トラウマ専門外来（大学病院・EMDR認定施設）

「やってはいけないこと」3つ： 1. 安定化なしにトラウマを詳しく掘り起こす 2. 「もう過去のことだから大丈夫」と軽く言う 3. 「問題患者」として切り捨て、紹介もしない

脚本: 「紹介のタイミングです。自傷・希死念慮が出たとき、解離症状が顕著なとき、そして通常の外来対応では感情のコントロールが困難なとき——これらは精神科・心療内科への紹介適応です。

可能であればDBTを提供できる施設や、トラウマ専門外来につなぐことが理想です。EMDR認定セラピストのいる施設も選択肢になります。

そして最後に——絶対にやってはいけない3つのことを確認します。

一つ目。安定化なしにトラウマを詳しく掘り起こすこと。『どんなことがありましたか、詳しく教えてください』と最初の診察で深掘りするのは禁物です。

二つ目。『もう過去のことだから大丈夫ですよ』と言うこと。これはC-PTSD患者には全く通じません。過去は今この瞬間も続いているような体験をしているのです。

三つ目。問題患者として切り捨て、紹介もしないこと。『あの人は何をしても無理だ』——この思考パターンが、最も患者を傷つけます。できなければできる施設へ。それが最大の支援です。」

クロージング（2分）

スライド17：キーメッセージの復習と質疑応答（2分）

[スライドに映す内容] 今日の3つのキーメッセージ：

1. C-PTSDは通常PTSDとは別物。DSO（情動調節困難・否定的自己概念・対人関係障害）を認識する。

2. フェーズ基盤型が原則。安定化なしにトラウマを急いで掘り起こしてはいけない。

3. 感情調節障害＋BPD共存C-PTSDにはDBT-PTSDが最強のエビデンス（寛解率58%、JAMA Psychiatry 2020）。

「問題患者」は「見落とされたC-PTSD患者」かもしれない。

脚本: 「最後にまとめます。今日お伝えしたかった3つのポイントです。

一つ目。C-PTSDは通常PTSDとは別の疾患単位です。DSOの3症状——情動調節困難、否定的自己概念、対人関係障害——これを意識的に拾うことから始まります。

二つ目。フェーズ基盤型が原則。急いでトラウマを掘り起こすのではなく、まず安全を確立して、感情調節スキルを身につけてから、そこでトラウマ処理に入る。

三つ目。感情調節障害が強くBPD基準を満たすようなC-PTSD患者には、DBT-PTSDが最も強いエビデンスを持ちます。JAMA Psychiatryの結果、寛解率58%——この数字を覚えておいてください（PMID: 32697288）。

今日のレクチャーを通じて一番伝えたかったのはこれです——『問題患者』は、実は『見落とされたC-PTSD患者』かもしれない。その視点を持つだけで、患者さんの人生は変わるかもしれません。

時間が来ましたので、ここで質疑応答に移ります。どんな質問でも歓迎します——臨床的なこと、研究的なこと、あるいは今日の症例についてでも。どうぞ。」

補足資料（任意配布用）

主要参考文献一覧

テーマ	著者・雑誌	PMID
ISTSSガイドライン	Bisson JI et al., J Trauma Stress, 2019	31283056
EMDRメタ解析	Karatzias T et al., Psychological Medicine, 2019	30857567
TF-CBT/PE/CPTメタ解析	Korovynskyi I et al., Georgian Medical News, 2025	40737648
DBT-PTSD RCT（JAMA Psychiatry）	Bohus M et al., JAMA Psychiatry, 2020	32697288
DBT-PTSD長期フォロー	Vonderlin R et al., Eur J Psychotraumatol, 2024	39221987
スキーマ療法	van Hemert MTC et al., Eur J Psychotraumatol, 2025	41160015
IFS パイロット		38934934

テーマ	著者・雑誌	PMID
	Comeau A et al., Psychol Trauma, 2024	
薬物療法アルゴリズム	Bajor LA et al., Psychiatry Res, 2022	36162349
ガイドライン最新版	Schaug JP et al., BMJ Mental Health, 2025	40234083

C-PTSD スクリーニングツール（参考）

- **ICD-TQ（International Trauma Questionnaire）** — ICD-11に基づくC-PTSD自己記入式スクリーニング
- **ITQ（International Trauma Questionnaire）** — C-PTSDの研究・臨床評価に広く使用

本脚本は*2026-03-20*作成。参照文献サマリー*: `/Users/torukubota/ai-management/docs/pubmed/2026-03-20_complex_PTSD_treatment_evidence.md`*